

ऑर्थोटोपिक नियोब्लैडर आपकी अपनी आँत के एक हिस्से से बना नया मूत्राशय है, जो मूत्रमार्ग से जोड़ा जाता है — ताकि मूत्राशय निकालने के बाद भी आप बिना बैग के सामान्य तरीके से पेशाब कर सकें। इसे अच्छी तरह खाली करना और नियंत्रण पाना सीखने में समय और अभ्यास लगता है।

इस प्रक्रिया के बारे में

लगभग **16–24 इंच छोटी आँत** को खोलकर कम-दबाव वाली थैली बनाई जाती है और **मूत्रमार्ग** से जोड़ी जाती है; मूत्रवाहिनियाँ (गुर्दों से आने वाली नलियाँ) इसमें जुड़ती हैं। **कोई stoma और कोई बैग नहीं** होता।

चूँकि नया मूत्राशय आँत से बना है, यह वैसा “जाना-है” संकेत **नहीं** देता, इसलिए आप सीखते हैं:

- **समय पर पेशाब करना** — पेल्विक फ़्लोर को ढीला करके और धीरे जोर लगाकर — **रात में उठकर भी**।
- यदि नियोब्लैडर पूरी तरह खाली न हो, तो catheter से निकालना (महिलाओं में अधिक सामान्य)।
- नियंत्रण बनाने के लिए **पेल्विक फ़्लोर व्यायाम (केगेल)** करना।

नियंत्रण **महीनों** में बेहतर होता है; शुरुआत में, विशेषकर रात में, मूत्र असंयम सामान्य है। यह विकल्प सभी के लिए नहीं है — यह मूत्रमार्ग, गुर्दों की कार्यक्षमता और दिनचर्या प्रबंधन पर निर्भर करता है।

क्या यह सुरक्षित है?

यह एक स्थापित विकल्प है जो सबसे “स्वाभाविक” परिणाम देता है। यह conduit की तुलना में बड़ी और लंबी सर्जरी है और इसमें अधिक सीखना व देखभाल करनी होती है। जोखिम में शामिल हैं: रक्तस्राव, संक्रमण, leak, दिन या रात मूत्र असंयम, catheter की ज़रूरत, mucus, मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI), और follow-up में देखे जाने वाले दीर्घकालिक नमक/विटामिन/गुर्दों के बदलाव।

शब्दों को समझें

नियोब्लैडर (Neobladder)

आँत के एक टुकड़े से बना नया मूत्राशय।

ऑर्थोटोपिक (Orthotopic)

मूत्रमार्ग से जोड़ा गया, ताकि आप सामान्य तरीके से पेशाब करें।

मूत्रमार्ग (Urethra)

वह नली जिससे पेशाब शरीर से बाहर जाता है।

मूत्रवाहिनी (Ureter)

गुर्दों से पेशाब लाने वाली नलियाँ; ये नियोब्लैडर में जुड़ती हैं।

समय पर पेशाब (Timed voiding)

इच्छा का इंतजार किए बिना, एक निश्चित समय-सारणी से पेशाब करना।

स्व-कैथेटराइज़ेशन

ज़रूरत पड़ने पर नियोब्लैडर खाली करने के लिए खुद पतली नली डालना।

पेल्विक फ़्लोर

वे मांसपेशियाँ जिन्हें आप मूत्र रोकने और छोड़ने के लिए मजबूत करते हैं।

Mucus

आँत द्वारा बनाया जाने वाला चिकना द्रव; पेशाब में धागे-जैसा दिखना सामान्य है।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए उस दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में पेट में दर्द होगा और आँत को “जागने” में कुछ दिन लगते हैं। आप catheter के साथ जागते हैं जो नए मूत्राशय में होता है (लगभग 2-3 हफ्ते)। अधिकांश लोग अस्पताल में 5-8 दिन रहते हैं।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- जनरल एनेस्थीसिया में होती है — सभी निर्देश मानें (उपवास, blood thinner बंद करें जैसा बताया जाए)। **bowel prep** हो सकती है।
- प्रतिबद्धता समझें: **दिन-रात समय पर पेशाब**, संभव **स्व-कैथेटराइज़ेशन**, और पेल्विक फ्लोर व्यायाम।
- धूम्रपान न करें** और घर पर मदद का इंतजाम करें।

पहले से अपनी टीम को बताएँ यदि आप:

- blood thinner** लेते हों, या कोई संक्रमण हो
- आँत की बीमारी, गुर्दे की समस्या, पेट की पूर्व सर्जरी या radiation हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- आप एनेस्थीसिया में सोते हैं और antibiotics दिए जाते हैं।
- आँत का एक हिस्सा अलग किया जाता है; बची हुई आँत फिर से जोड़ी जाती है।
- उस हिस्से को खोलकर थैली बनाई जाती है और मूत्रमार्ग से सिली जाती है।
- मूत्रवाहिनियाँ थैली से जोड़ी जाती हैं; catheter और soft stents लगाए जाते हैं।

बाद में

- लगभग **5-8 दिन** बाद घर जाते हैं; **catheter ~2-3 हफ्ते** रहता है; mucus साफ करने के लिए flush कर सकते हैं।
- Catheter निकालने से पहले नियोब्लैडर का **healing X-ray** होता है।
- फिर **समय पर पेशाब** (रात में alarm), पेल्विक फ्लोर व्यायाम, और ज़रूरत पर **स्व-कैथेटराइज़ेशन** सीखते हैं।
- शुरुआत में **मूत्र असंयम** (खासकर रात में) सामान्य है; महीनों में सुधार होता है। Mucus सामान्य है; तरल पदार्थ पीएँ; आजीवन follow-up ज़रूरी है (विटामिन B12 सहित)।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- पेशाब नहीं हो रहा** या catheter **बंद हो गया**
- पेट में तेज दर्द, उल्टी, या **गैस/मल नहीं आ रहा**
- अधिक रक्तस्राव, घाव में लालिमा/discharge, या बाजू में दर्द

याद रखने योग्य तीन बातें

- नियोब्लैडर आँत से बना नया मूत्राशय है जो मूत्रमार्ग से जुड़ा है — कोई बैग नहीं।
- अभ्यास ज़रूरी है: दिन-रात समय पर पेशाब, पेल्विक फ्लोर व्यायाम, और कभी-कभी स्व-कैथेटराइज़ेशन। नियंत्रण महीनों में आता है; शुरुआती असंयम सामान्य है।
- उपवास और bowel prep निर्देशों का पालन करें, धूम्रपान न करें। Healing X-ray के बाद ही टीम catheter निकालेगी; पेशाब न हो या catheter बंद हो तो तुरंत बुलाएँ।